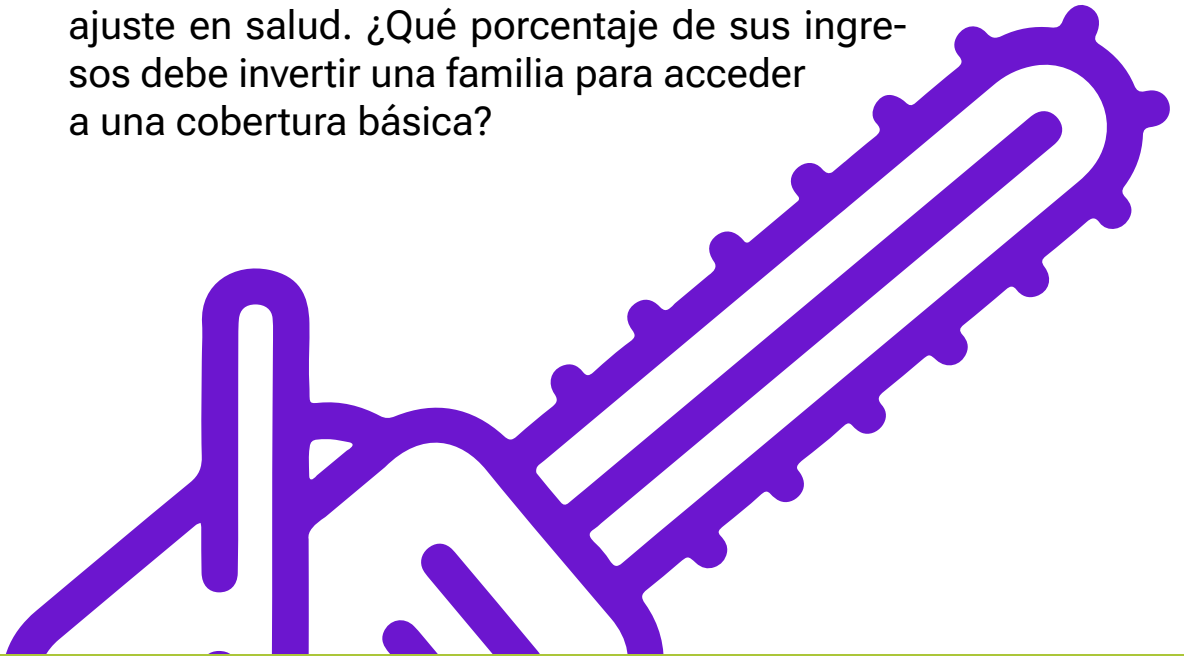


No era la casta, eras vos

El impacto del ajuste en la salud Santa Fe

Desregulación de las tarifas para las empresas de medicina prepaga. Aumentos en medicamentos. Ajuste en el PAMI y en IAPOS. Al feroz aumento en los servicios esenciales se suma el ajuste en salud. ¿Qué porcentaje de sus ingresos debe invertir una familia para acceder a una cobertura básica?



Comunidad

En el informe anterior, que abordaba el impacto de los servicios esenciales en los ingresos de santafesinos y santafesinas, mostramos que el ajuste no recayó sobre la casta, tal como prometía en campaña Javier Milei, sino sobre la gente: 24,2% de la motosierra fue sobre jubilaciones y pensiones, 23,6% sobre obra pública y 12,8% sobre prestaciones sociales.

Con tenues intentos discursivos para intentar marcar alguna diferencia, pero votando cada ley que impulsó Milei en el Congreso, el gobierno provincial adhirió a la lógica nacional del recorte sobre los sectores más vulnerables. Según el gobernador Maximiliano Pullaro, el ajuste se realizó sobre “los sueldos más altos, del Poder Ejecutivo, Judicial y Legislatura”. Esto es falso: el poder adquisitivo de los trabajadores respecto a servicios básicos (transporte público, electricidad, gas y agua) cayó en la Provincia.

Los números no mienten:

- * Los salarios de docentes, trabajadores municipales y empleados de comercio crecieron apenas por encima del 200% .
- * Las jubilaciones menos de 150%.

Al mismo tiempo:

- * La tarifa de la Empresa Provincial de la Energía para ingresos medios aumentó 663%.
- * La tarifa de gas natural aumentó 431%.
- * La tarifa de Aguas Santafesinas aumentó 913%.
- * El boleto de colectivo aumentó 618%.

Llegar a fin de mes se hace imposible. Por eso baja el consumo y el endeudamiento de las familias crece a niveles nunca antes alcanzados. Pagar los servicios esenciales (agua, luz, gas, transporte público) pasó de representar entre el 6% y el 9% de los ingresos de una persona a ubicarse entre el 16% y 21%.

Y esa cifra representa sólo una parte de las obligaciones que las familias deben afrontar mes a mes. ¿Cuánto deben invertir, además, en salud?



Medicina Prepaga

El DNU 70/2023, al que el gobierno llamó “Bases para la Reconstrucción Argentina”, liberó precios para maximizar las ganancias de las empresas de medicina prepaga y farmacéuticas, mientras la política económica del gobierno de Milei pisó los ingresos de trabajadores estatales, jubilados y las paritarias del sector privado.

Según Milei, esta decisión iba a aumentar la competencia, lo que derivaría en una mejor oferta y calidad de los servicios, más una baja en los precios. Ocurrió exactamente lo contrario. Tal es así que el gobierno se vio obligado a intervenir, presentó denuncias por “cartelización” y obligó a algunas empresas a retrotraer tarifas a través de una resolución de la Secretaría de Comercio del Ministerio de Economía.

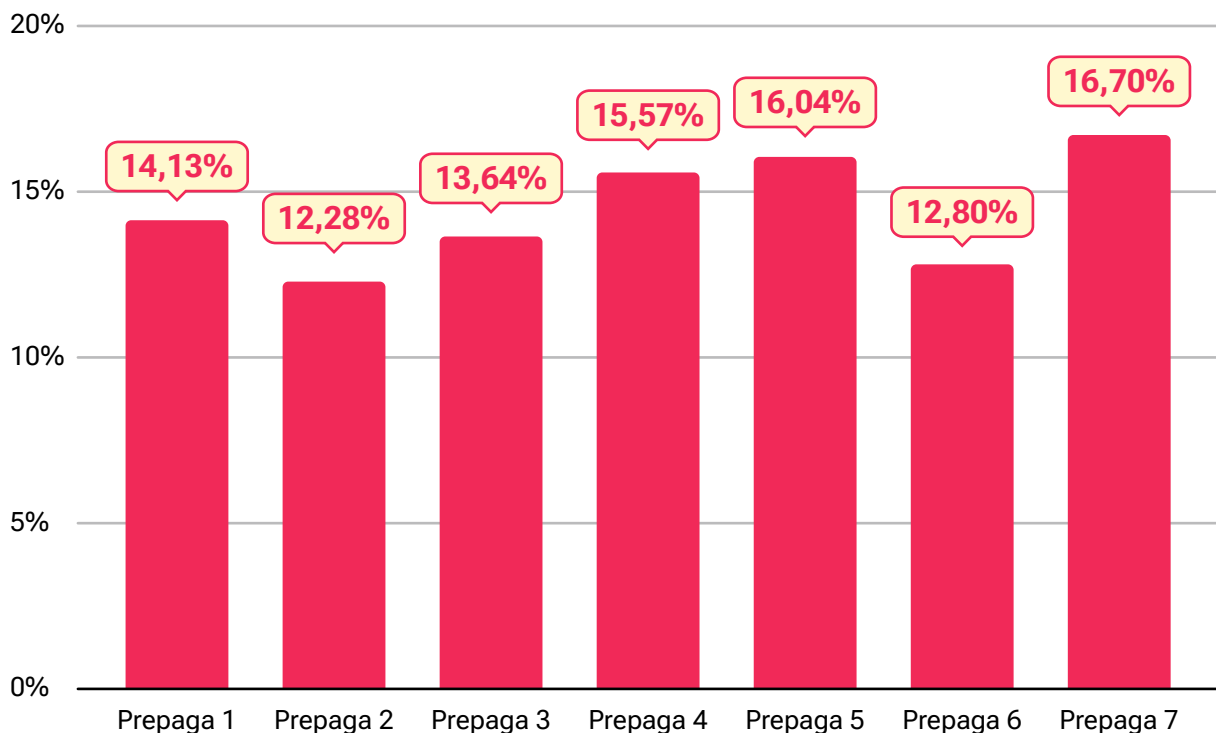
Todos los meses el Instituto Provincial de Estadísticas y Censos (IPEC) elabora el Índice de Precios al Consumidor. Una de las variables que mide es el ítem “Servicios de Salud”, que incluye “sistema prepago de asistencia médica, consultas médicas y odontológicas, análisis clínicos y radiológicos”. En ese rubro el gobierno provincial estimó la inflación en 353% entre diciembre de 2023 y julio de 2025 (último dato disponible), muy por encima de los aumentos otorgados a los gremios estatales, del aumento de jubilaciones, salario mínimo, ingresos promedio medidos por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) y de lo conseguido en paritarias del sector privado. También por encima del Índice de Precios al Consumidor registrado por el propio IPEC (231%).

Desde Comunidad hicimos un relevamiento para saber cuál es el costo que debe afrontar una persona en una empresa de medicina prepaga en la ciudad de Santa Fe. Consultamos a Swiss Medical, AMUR, Prevención Salud, Sancor Salud, OSDE, Jerárquicos Salud y Medifé. El precio para una persona adulta, con monotributo, es el siguiente (no se especifica cuál es cuál, porque más allá de ser el plan básico de cada una de esas empresas, cada una ofrece servicios distintos y no es el objetivo de este informe compararlos, sino saber qué opciones tiene una persona para tener cobertura médica):

Prepaga 1	\$121.919
Prepaga 2	\$106.000
Prepaga 3	\$117.007
Prepaga 4	\$134.360
Prepaga 5	\$138.397
Prepaga 6	\$110.423
Prepaga 7	\$144.078

Según la última publicación del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, el ingreso promedio del estrato medio de la población ocupada (no asalariada) fue de \$862.535. Tomando en cuenta estas seis opciones relevadas por Comunidad, un plan de medicina prepaga para una persona adulta en la ciudad de Santa Fe representa una erogación de entre el 12,28% y el 16,70% de sus ingresos mensuales.

¿Qué porcentaje de sus ingresos debe invertir un/a monotributista en Santa fe para acceder a una prepaga?



En nuestro informe anterior mostramos de qué manera los servicios esenciales (las tarifas de electricidad, gas natural, agua y transporte público) habían pasado de representar el 7,52% de los ingresos medios de los asalariados en diciembre de 2023 al 15,95% en la actualidad (ahora más, debido a los nuevos aumentos en la EPE y el boleto de colectivo). En el caso de los ingresos medios de los no asalariados, también medidos por INDEC, pasó de representar el 9,53% al 19,36%.

En números concretos, un consumo promedio de electricidad, agua y gas natural representa para un hogar \$68.948 por mes. Tomar dos colectivos por día hábil implica un gasto de \$69.520. Si a eso se le suma un plan de medicina prepaga, según las opciones relevadas por Comunidad, una persona debe destinar entre \$244.468 y \$282.546 por mes, lo que representa entre el 28,34% y el 32,75% del ingreso promedio de los estratos medios de la población ocupada.



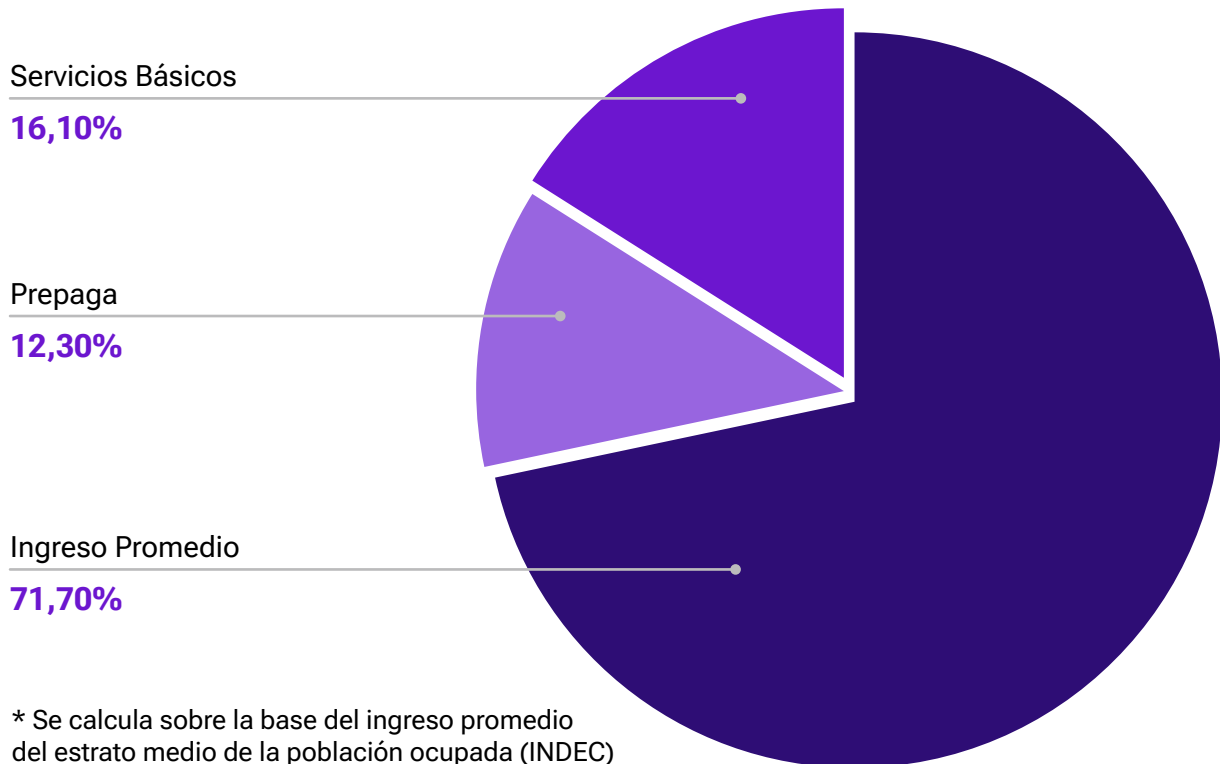
SERVICIOS BÁSICAS + PREPAGA

\$244.468 / \$282.546

por mes en Santa Fe



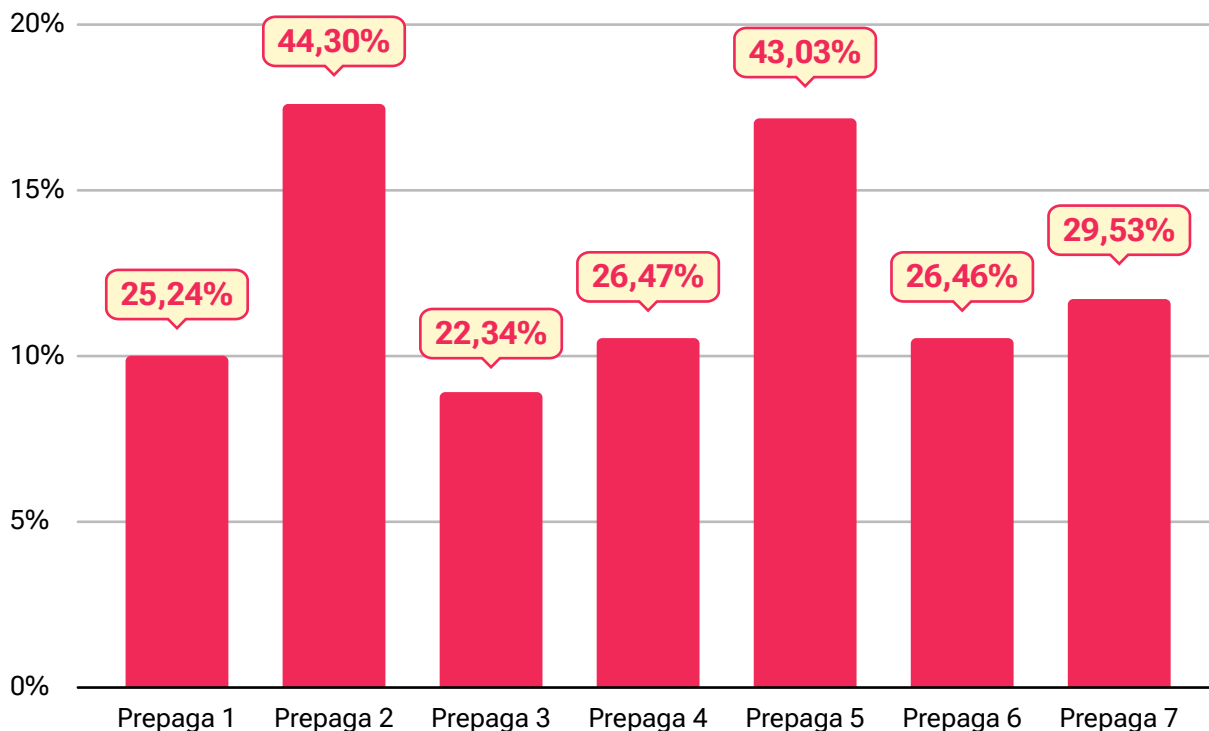
¿Qué porcentaje del ingreso le queda a una persona después de pagar servicios básicos y salud?



Opción 1	\$435.439
Opción 2	\$764.223
Opción 3	\$385.454
Opción 4	\$456.648
Opción 5	\$742.456
Opción 6	\$456.489
Opción 7	\$509.463

Es decir que en el caso de una familia en la que las dos personas adultas tengan el ingreso promedio de los estratos medios de la población ocupada, acceder a un plan de salud básico de una empresa de medicina prepaga representa entre el 22,34% y el 44,30% de sus ingresos.

¿Qué porcentaje de sus ingresos debe invertir una familia con ingresos promedios para acceder a una prepaga?



Teniendo en cuenta el costo de los servicios básicos antes enumerados (electricidad, gas natural, agua potable y transporte público), pagar esas tarifas más una empresa de medicina prepaga para una familia representa como mínimo el 34,40% de sus ingresos, pudiendo llegar hasta el 55,09% dependiendo de la opción elegida. Eligiendo la cobertura más barata le queda un 65% de sus ingresos, sin contar otros gastos como educación, alimentos y vivienda, mucho más si se trata de un alquiler.



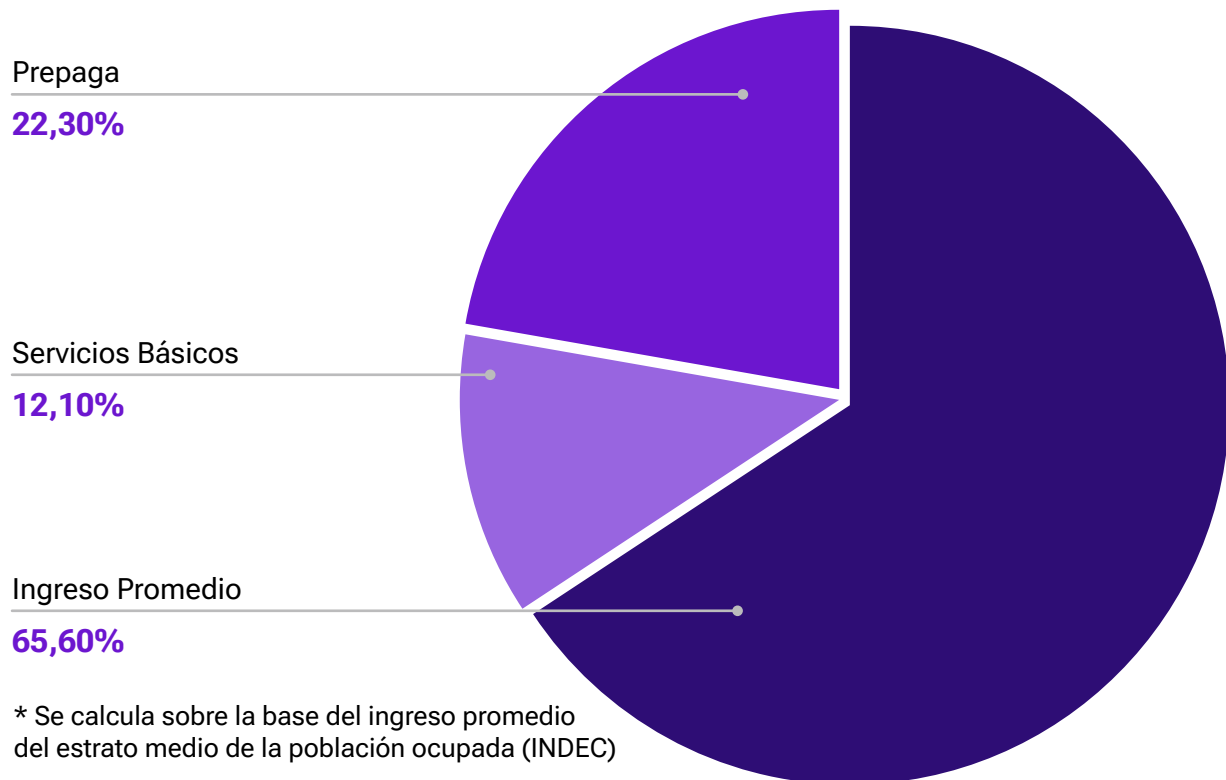
SERVICIOS BÁSICAS + PREPAGA

\$593.442 / \$950.442

por mes en Santa Fe



¿Qué porcentaje de sus ingresos le queda a una familia después de pagar servicios básicos y prepaga?





Medicamentos y PAMI

El acceso a los medicamentos, especialmente para las personas mayores, es uno de los pilares del derecho a la salud. Sin embargo, desde la asunción de Milei ese derecho fue severamente restringido a través de una política deliberada de desfinanciamiento, recortes en la cobertura y aumentos sostenidos de precios en el sistema del PAMI. Lejos de tratarse de un problema administrativo o transitorio, el recorte forma parte del mismo patrón de ajuste que se impuso sobre los servicios públicos: la transferencia del costo a quienes menos pueden afrontarlo.

El DNU 70/2023 derogó la Ley 27.113, que declaraba de interés nacional y estratégico la actividad de los laboratorios de producción pública y creó la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos (ANLAP), sancionada en 2014 y reglamentada en 2015. Los laboratorios industriales estatales y las farmacias hospitalarias producen una gran cantidad de medicamentos en el país, muchos de ellos “no rentables” para el sector privado. La ANLAP era una herramienta clave no sólo para eso, sino también para desarrollar estrategias que le permitan al Estado regular los precios.

Al igual que con las empresas de medicina prepaga, las medidas del gobierno de Milei en el área de los medicamentos buscan aumentar las extraordinarias ganancias de la industria farmacéutica. La disminución de controles para evitar la adulteración y falsificación de medicamentos que garanticen la trazabilidad de los fármacos es un riesgo enorme para la población. El mayor ejemplo es lo ocurrido con el fentanilo contaminado, que provocó al menos 30 muertes en la provincia.

Entre noviembre de 2023 y febrero de 2025, según un informe publicado por la Fundación Soberanía Sanitaria, el gasto de bolsillo de los jubilados en medicamentos aumentó un 382%, mientras que la cantidad de remedios dispensados cayó un 26%. El Gobierno Nacional, que se jacta de haber alcanzado el superávit fiscal, lo hizo en parte gracias a una decisión política: dejar que el sistema de salud se sostenga sobre el ingreso de quienes dependen de él. En paralelo, desde mediados de 2024, el PAMI comenzó a reducir la canasta de medicamentos con cobertura al 100%, excluyendo más de un millar de principios activos esenciales.

Millones de jubilados y jubiladas en el país tenían cobertura total en miles de medicamentos y ahora ya no lo tienen. Para acceder a ese beneficio ahora el afiliado debe demostrar ingresos por debajo de 1,5 jubilaciones mínimas, no tener vehículo, propiedades, prepaga ni ahorros. Una persona que apenas supera ese umbral pierde automáticamente el acceso, a menos que gestione un subsidio social, cuyo trámite es engorroso y muchas veces inaccesible para quienes más lo necesitan.

Una persona consultada por Comunidad, que debe tratarse por tiroides de por vida, explicó que PAMI le reconocía “la totalidad del medicamento, y ahora un porcentaje muy bajo”. En otro caso, una mujer expresó que, como consecuencia de una diabetes, la recomendación es que cuide su piel con crema con vitamina D. “Antes me reconocía un porcentaje, ahora directamente nada”, contó.

El resultado es previsible y brutal: una enorme cantidad de personas mayores interrumpieron tratamientos, redujeron dosis o dejaron de comprar sus medicamentos. Enfermedades crónicas sin seguimiento, cuadros que se agravan, internaciones evitables. Todo para que “cierren las cuentas”.

Desde Comunidad relevamos, luego de hablar con distintos especialistas en salud, el precio de 20 medicamentos y su variación desde diciembre de 2023 a la fecha. Más de la mitad aumentaron por encima de la inflación registrada por el IPEC en ese período (231%), llegando hasta el 349% de incremento. Cabe recordar que los salarios crecieron apenas por encima del 200%, mientras que las jubilaciones lo hicieron por debajo de 150%, lo que muestra la pérdida del poder adquisitivo de las familias no sólo ante los servicios públicos, sino también ante la salud.

DROGA	TIPO	UNIDAD	2023	2025	%
Acenocumarol	Anticoagulante	4gx20	\$11.050	\$26.171	137%
Allopurinol	Para la gota	100mgx30	\$1.721	\$5.388	213%
Amlodipina	Antihipertensivo	10mgx30	\$8.852	\$29.087	229%
Atenolol	Antiarrítmico	50mgx30	\$3.874	\$17.414	349%
Atorvastatin	Dislipemia	10mgx30	\$10.462	\$34.752	232%
Budesonide/Formoterol	EPOC / Asma	120 dosis	\$31.136	\$111.650	259%
Carbamezapina	Antiepiléptico	200mgx30	\$5.561	\$19.702	254%
Carvedilol	Antiarrítmico	10mgx30	\$6.082	\$18.809	209%
Dorzolamida/Timolol	Glaucoma	5ml	\$10.747	\$42.087	292%
Enalapril	Antihipertensivo	10mgx30	\$3.191	\$8.967	181%
Furosemida	Diurético	40mgx50	\$11.008	\$22.832	107%
Gabapentin	Anticonvulsivo	100mgx30	\$5.698	\$22.229	290%
Levotiroxina	Hipotiroidismo	125mgx50	\$8.234	\$31.779	286%
Losartan	Hipertensivo	50mgx30	\$7.207	\$24.022	233%
Oxycarbazepina	Antiepiléptico	600mgx30	\$36.484	\$120.476	231%
Risperidona	Antipsicótico	3mgx60	\$31.385	\$105.309	236%
Salbutamol	Asma / EPOC	5ml	\$1.979	\$5.486	177%
Clopidogrel	Antiag. Plaquetario	75mgx30	\$17.161	\$59.905	249%
Mesalazina	Tto. Colitis ulcerosa	500mgx60	\$38.893	\$153.791	295%
Hidroclorotiazida	Diurético	50mgx30	\$2.895	\$7.943	174%



PAMI

En el informe anterior nos referimos brevemente al ajuste que realizó el gobierno de Pullaro sobre el Instituto Autárquico Provincial de Obra Social (IAPOS), la obra social de los trabajadores y trabajadoras públicos de la provincia.

El impacto más visible de esa política está en el pago de los coseguros:

- * El bono de IAPOS pasó de costar \$70 en diciembre de 2023 a \$900 hoy (1.185% más).
- * Una orden de consulta pasó de \$350 a \$3.600 (928% más).
- * Una orden de internación pasó de \$1.380 a \$36.000 (2.508%).

Estos valores están absolutamente por encima de la inflación registrada por el propio gobierno provincial (231%) También, muy por encima de los aumentos a estatales, que apenas superan el 200%.



AUMENTOS

↑ 1185%

Bono

↑ 928%

Orden de Consulta

↑ 2508%

Orden de Internación

231%

Inflación (IPEC)



Quienes utilizan la obra social pública saben que para cualquier consulta el pedido de bonos que hace el profesional empieza en 15 y en algunos casos, dependiendo la complejidad del tratamiento o estudio, se puede estirar hasta 60 u 80, por lo que además del aporte que el trabajador hace a través de los descuentos a su salario, paga entre \$13.500 y \$72.000 cada vez que asiste a un profesional de la salud. Esto siempre y cuando el profesional no cobre plus, porque más allá de la posibilidad del afiliado de denunciar ese pago desde la App de IAPOS, es una práctica que no se modificó, de acuerdo a innumerables testimonios de afiliados y afiliadas consultados por Comunidad.

Además, la actual gestión decidió incorporar otros dos nuevos bonos que entraron en vigencia el 1° de julio de 2025: el Bono Quirúrgico (BQ) que “se aplica sin excepción a toda internación con procedimiento quirúrgico” y a “prácticas quirúrgicas ambulatorias”; y el Bono de Prestaciones Especiales (BPE) “destinado a prácticas y servicios de alto costo”. El costo de los mismos es de \$54.000 y \$180.000, respectivamente. Son bonos que no existían: algún estudio (como una tomografía) se pagaba aparte con bonos, pero la cirugía estaba cubierta dentro del bono de internación. En definitiva, otro golpe al bolsillo de afiliados y afiliadas.

El ajuste es visible también en las prestaciones. Es casi imposible conseguir un pediatra, un sicólogo o un psiquiatra que atienda por IAPOS, lo que deriva casi inevitablemente en un pago a un profesional por fuera de la cobertura que el abonado paga todos los meses al Estado a través de los descuentos a su salario.

Servicio Complementario

¿Cuál es el aporte que hacen trabajadoras y trabajadores públicos con sus salarios? El 2,25% por cada afiliado voluntario en actividad y 2,75% para titulares pasivos. Además, por cada afiliado voluntario se descuenta la cuota correspondiente al Servicio Complementario. Se trata de un aporte para acceder a una cobertura “de importancia y elevado valor económico que no se encuentra comprendido en la cobertura universal obligatoria”, según puede leerse en la web oficial.

Hasta mayo de este año ese aporte estaba definido por la disposición 62 del 5 de diciembre de 2017 (gobierno del mismo signo político que el actual). Allí se detalla que “se considera razonable establecer como valor del aporte al servicio complementario, la cantidad de 4 (cuatro) órdenes de consulta médicas, garantizando de este modo la

actualización del monto conforme la variación del valor de la consulta tomada como referencia”. Teniendo en cuenta esa referencia, el Servicio Complementario costaba \$1.400 en diciembre de 2023 (la orden de consulta era de \$350) y debiera costar hoy \$14.400, de acuerdo a la actualización de la orden que realizó el propio gobierno.

Sin embargo, a partir de la disposición 23 del 12 de mayo de este año, esa ecuación cambió: el aporte base pasó a ser de \$20.000 por cada afiliado (39% más que lo establecido por el cálculo anterior), lo que provocó la crítica de distintos gremios estatales, quienes denunciaron que esa medida “implica incrementos de hasta 30% sobre el aporte mensual en un contexto de pérdida salarial”, “un Estado que transfiere más costos de salud a los trabajadores mientras continúa el cobro de plus”, y que un aumento tan grande “licúa el magro aumento salarial del gobierno”.

Más allá del innegable impacto en el bolsillo de trabajadoras y trabajadores públicos, es una medida absolutamente regresiva, porque afecta mucho más a quienes cobran menos: quien percibe una jubilación mínima en la provincia debiera aportar alrededor de \$7.400, pero sin embargo debe ir hacia la base que definió la actual gestión, que es de \$20.000 (170% más). En cambio, quienes más cobran, tienen la posibilidad de deducir de ganancias esos aportes, por lo que les representa un esfuerzo mucho menor.

Sistema Abierto

El Sistema Abierto le permite a quienes hayan sido titulares de la obra social y deseen continuar con la cobertura de IAPOS hacerlo a través de un pago mensual.

La disposición 36 del año 2017 (se insiste, gobierno del mismo signo político que el actual) estipulaba que “la cuota abonada por estos afiliados deberá cubrir tanto el concepto de aporte personal (3,5%) como el valor correspondiente a la contribución patronal (6%), cuando no registran un empleador que efectúe, por separado, dichas contribuciones al I.A.P.O.S”. Luego detallaba lo siguiente: “Los porcentajes indicados se calcularán sobre el monto equivalente a la remuneración de una Categoría 4, Agrupamiento Administrativo - Decreto Acuerdo 2695/83 y modificatorios, de la Administración Pública Central, conforme valor referencial determinado por la Dirección General de Administración”.

Es decir que para calcular el monto de la cuota se tomaba como referencia el ingreso de la categoría 4 y se actualizaba en cada paritaria. Desde el inicio de la gestión actual ese cálculo se modificó por completo. En la disposición 49 del año 2024 se dejó de lado la Categoría 4 como referencia y pasó a calcularse sobre “el monto equivalente a la remuneración en base promedio de categorías 5 y 6 Agrupamiento Administrativo”, lo que implicó un primer ajuste, y a partir del 30 de mayo de 2025, con la disposición 27 pasó a utilizarse como referencia “el aporte de la categoría 6 agrupamiento administrativo Decreto Acuerdo 2695/83 y modificatorios fijados por la Administración Pública Central”.

Eso modifica completamente el cálculo de las cuotas, lo que se desprende de las propias disposiciones de IAPOS:

- * En julio de 2024 un titular del sistema abierto pagaba \$107.850 un titular con hasta tres integrantes del grupo primario \$119.202.

- * Desde mayo de 2025 un titular pasó a pagar \$229.237 (112% más) y un titular con hasta tres integrantes del grupo primario \$401.164 (237% más).

En ese período, el IPEC midió 31,6% de inflación.

Si la comparación es con diciembre de 2023, el feroz ajuste sobre la obra social pública de la provincia (en este caso sobre el sistema abierto) queda aún más claro:

- * En diciembre de 2023 una persona pagaba por el Sistema Abierto \$36.392 (\$34.192 de obra social y \$2.200 de Servicio Complementario).

- * Hoy una persona paga \$291.954 (\$266.954 de obra social y \$25.000 de Servicio Complementario).

Esto representa un incremento de 702%, contra 231% de inflación medida por el propio IPEC.



↑702%
Aumentos



231%
Inflación (IPEC)



Lo llamativo es que una persona que quiera seguir dentro de IAPOS, en este caso utilizando el Sistema Abierto, debe pagar más del doble que en la mayoría de las opciones de medicina prepaga relevadas por Comunidad.

La salud como privilegio

El ajuste no es una abstracción, no es intangible: se mide en remedios que se dejan de comprar, en turnos médicos que se postergan, en tratamientos que se abandonan por falta de dinero. Detrás de cada plan recortado, de cada cobertura encarecida, hay una persona que se quedó sin atención, un jubilado que eligió entre la medicación o la comida, una familia que calcula si podrá pagar la cuota de la prepaga o la tarifa de la EPE.

En nombre de la austeridad, el acceso a la salud se volvió cada vez más difícil. No es casualidad, es un modelo. Los aumentos en medicamentos, la desregulación de las prepagas, los recortes en IAPOS y PAMI y la caída de los programas públicos conforman una misma política: el ajuste como único destino posible. No se trata sólo de achicar números, sino de reducir derechos.

Mientras los salarios corren detrás de los precios, los servicios de salud se alejan de lo posible. Cada consulta cuesta más, cada análisis se paga aparte, acceder a una cobertura se vuelve una amenaza económica. Lo que antes era un esfuerzo hoy es directamente un privilegio. Y aunque los discursos oficiales insistan en que se trata de “ordenar las cuentas”, lo que se ordena, en realidad, es la desigualdad.

Santa Fe no es la excepción: los aumentos en las prepagas y el desfinanciamiento del sistema público son parte del mismo relato que celebra el superávit fiscal mientras desmantela la red que garantiza atención y cuidado. El Estado retrocede y cada ciudadano queda librado a su suerte.

El ajuste no es sólo una política económica: es disciplinador. Traza una línea que separa a quienes pueden acceder a la salud de quienes sólo pueden esperar. Y esa espera, en un país que naturalizó el sufrimiento como precio del equilibrio, se vuelve interminable. No hay orden posible cuando el Estado se retira y abandona a cada uno a su suerte, cuando enfermarse implica endeudarse. Lo que está en juego no es sólo la salud pública. Es la forma en que una sociedad decide quién merece vivir con dignidad.



Comunidad

Comunidad

Comunidad

Comunidad